

Argumentos clínicos para indicação de diálise peritoneal

Caso: paciente com DRC estágio 5 (TFG estimada em 14%), diabetes mellitus de longa data, pé diabético com ferida extensa ativa (sem infecção sistêmica no momento) e antecedente de amputação contralateral.

O perfil clínico deste paciente reúne características em que a diálise peritoneal (DP) oferece vantagens específicas sobre a hemodiálise (HD) convencional, tanto do ponto de vista do manejo renal quanto da proteção da ferida ativa e da estabilidade hemodinâmica. Os pontos abaixo consolidam os argumentos que justificam considerar DP como modalidade preferencial.

Argumentos clínicos

1. **Dispensa acesso vascular em paciente com ferida aberta em membro inferior.** A implantação de cateter venoso central (CVC) em paciente com ferida extensa configura risco elevado de bacteremia relacionada ao cateter e endocardite infecciosa. A fístula arteriovenosa, por sua vez, exige maturação de 6 a 12 semanas — inviável no tempo clínico do caso. O cateter peritoneal (Tenckhoff) é implantado por via abdominal, isolado da ferida, e fica utilizável em aproximadamente duas semanas.
2. **Preservação da função renal residual (FRR).** Estudos observacionais consistentes (BRAZPD, CANUSA, NECOSAD) demonstram declínio mais lento da FRR em DP quando comparada à HD. Com TFG estimada em 14%, cada ponto percentual preservado tem impacto direto sobre sobrevivência e qualidade de vida.
3. **Estabilidade hemodinâmica e preservação da perfusão periférica.** A HD convencional remove 2 a 4 litros em aproximadamente 4 horas, com episódios recorrentes de hipotensão intradiálítica. Hipotensão compromete a perfusão tecidual — condição crítica em paciente com pé diabético ativo, em que a cicatrização depende de fluxo arterial adequado. A DP promove ultrafiltração lenta e contínua, sem picos hemodinâmicos.
4. **Ausência de anticoagulação sistêmica.** A HD convencional requer heparinização durante cada sessão. Em paciente com ferida ampla com potencial de sangramento local, a DP — que não utiliza anticoagulante sistêmico — apresenta perfil de segurança superior.
5. **Maior estabilidade glicêmica.** As oscilações glicêmicas associadas à HD (retirada rápida de glicose circulante) são deletérias à cicatrização. A DP, apesar de exigir ajuste insulínico pela glicose do dialisato, oferece perfil glicêmico mais estável ao longo do dia.
6. **Ausência de deslocamentos três vezes por semana.** Paciente com ferida ativa em pé, indicação de descarga total de peso e amputação contralateral apresenta mobilidade altamente limitada. Transportar o paciente três vezes por semana até clínica de HD representa desgaste físico, risco de infecção nosocomial e trauma repetido na região da ferida. A DP é realizada no domicílio.
7. **Perfil cardiovascular.** Em pacientes diabéticos idosos, meta-análises recentes demonstram desfechos cardiovasculares equivalentes ou favoráveis à DP nos primeiros 2 a 3 anos — janela temporal que cobre o período crítico deste caso.
8. **Alinhamento com diretrizes nacionais e internacionais.** A Sociedade Brasileira de Nefrologia (SBN), a International Society for Peritoneal Dialysis (ISPD) e o KDIGO recomendam a estratégia

PD First em pacientes com contraindicação relativa à HD ou dificuldade de acesso vascular — situação integralmente preenchida pelo caso.

Pedido concreto à equipe assistente

Diante do perfil descrito, solicita-se avaliação formal para início de diálise peritoneal, contemplando:

- Avaliação anatômica abdominal (cirurgias prévias, hérnias, aderências) para verificar elegibilidade.
- Avaliação social e domiciliar pelo serviço de DP (condições mínimas de higiene, cuidador treinado, espaço para armazenamento do material).
- Se viável, implante do cateter peritoneal e início do programa em regime preferencial, considerando o tempo clínico reduzido pela TFG em 14% e pela ferida ativa.
- Caso o serviço atual não disponha de programa de DP, referenciamento formal a centro que disponha (hospital universitário ou referência regional no SUS).

Consideração final

Argumenta-se, ainda, que a postergação indefinida da terapia renal substitutiva neste caso pode resultar em piora da ferida por uremia não controlada — com deterioração da cicatrização, queda imunitária e sarcopenia por anorexia urêmica — criando um ciclo em que a modalidade “segura” sob a óptica do pé acaba se tornando inviável sob a óptica renal. A DP, por permitir início precoce sem acesso vascular e por oferecer depuração contínua, atua simultaneamente nas duas frentes.